Apoio Matricial na Atenção Primária à Saúde

PONTOS IMPORTANTES

- PONTOS IMPORTANTES
- O Apoio Matricial é uma estratégia fundamental para a integralidade do cuidado na Atenção Primária à Saúde (APS).
- Promove a colaboração interdisciplinar entre equipes de Saúde da Família (eSF) e Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).
- Atua nas dimensões técnico-pedagógica e assistencial, fortalecendo a capacidade resolutiva das eSF.
- Sua implementação enfrenta desafios como a falta de conhecimento e dificuldades relacionais, exigindo educação permanente.

Educação Permanente em Matriciamento

A educação continuada e a formação dos profissionais de saúde são cruciais para o sucesso do Apoio Matricial. Programas de capacitação devem ser implementados para familiarizar os profissionais com as práticas de matriciamento e desenvolver as competências necessárias para a implementação eficaz das estratégias de cuidado, especialmente em áreas com lacunas de conhecimento[12].

No entanto, a implementação do Apoio Matricial enfrenta desafios significativos. A falta de conhecimento adequado sobre o Apoio Matricial entre gestores e profissionais de saúde pode prejudicar a aplicação das práticas e ferramentas propostas, resultando em uma implementação ineficaz. Isso inclui a ausência de participação ativa dos profissionais e o estigma associado às condições de saúde, que pode impactar a adesão ao modelo[12]. Além disso, dificuldades relacionais e organizacionais são comuns, com problemas como a fragmentação do cuidado e a ausência de uma abordagem sistemática enfraquecendo a integração entre os serviços. Um estudo qualitativo objetivou analisar as concepções sobre matriciamento em saúde mental, evidenciando essas dificuldades[6].

Desafios na Implementação do Apoio Matricial

A falta de conhecimento sobre o Apoio Matricial por parte de gestores e profissionais, a baixa participação ativa das equipes e o estigma associado a certas condições de saúde podem comprometer a eficácia da implementação. Dificuldades relacionais e organizacionais, como a fragmentação do cuidado, também representam barreiras significativas[12].

A formação acadêmica inadequada dos profissionais constitui outro desafio identificado. A ausência de uma base sólida em práticas de matriciamento pode limitar a capacidade dos profissionais de aplicar efetivamente as estratégias propostas. A educação permanente é essencial para superar essas barreiras e aprimorar a compreensão e a eficácia das práticas matriciais[12]. Adicionalmente, um estudo realizado em Itapevi, SP, revelou dificuldades específicas nas ações de saúde na Atenção Básica, tais como a baixa capacidade de identificar demandas e riscos, a tendência à medicalização e a reduzida participação dos usuários. Apesar dessas dificuldades, foram alcançados avanços significativos na percepção dos trabalhadores e na mobilização de recursos internos para o cuidado, servindo como base para a introdução do matriciamento[13].

Como Funciona na Prática

Na prática, o Apoio Matricial materializa-se por meio de consultas conjuntas, visitas domiciliares coordenadas, grupos terapêuticos e outras intervenções que respondem de forma abrangente às demandas variadas de saúde[1]. Essas práticas não apenas ampliam o acesso aos cuidados, mas também melhoram a

continuidade do atendimento, garantindo uma resposta mais efetiva às necessidades específicas dos usuários, especialmente aqueles com condições crônicas e complexas.

Um estudo analisou as práticas e concepções do matriciamento em saúde mental a partir das perspectivas de equipes de referência, equipes matriciais e gestores. Foram realizadas entrevistas com 41 participantes e observações de 110 horas das práticas matriciais. O estudo revelou duas principais concepções sobre o matriciamento: como uma oportunidade de encontro produtivo entre equipes de saúde e como uma estratégia de formação em serviço. As observações confirmaram a necessidade de criar, sistematizar e fortalecer espaços de diálogo entre equipes de referência, equipes matriciais e gestores para consolidar o matriciamento e aprimorar suas práticas[5].

Potenciais de Organização Futura

Para o futuro, o Apoio Matricial pode expandir-se por meio da integração intersetorial com serviços sociais, educacionais e comunitários[9]. Esta integração é crucial para fortalecer as redes de cuidado, permitindo uma abordagem mais holística dos determinantes sociais da saúde. A colaboração com esses setores pode não apenas melhorar o acesso e a qualidade dos serviços, mas também promover ações preventivas e educativas que são fundamentais para a saúde comunitária.

Além disso, a implementação de tecnologias da informação e comunicação (TICs) pode otimizar a gestão de casos e facilitar o compartilhamento de informações entre as Equipes de Saúde da Família e os serviços especializados. As TICs possuem o potencial de aprimorar a coordenação dos cuidados, apoiar a educação continuada dos profissionais de saúde e garantir que informações cruciais estejam acessíveis para todos os envolvidos no cuidado. Essas inovações tecnológicas podem contribuir para uma gestão mais eficiente e integrada dos cuidados, elevando a qualidade dos serviços prestados.

Um exemplo relevante dessa abordagem é a proposta de intervenção desenvolvida na Região de Saúde de Cruz das Almas. Esta proposta visa aprimorar a articulação entre as Equipes de Saúde da Família (eSF) e os serviços existentes, por meio da criação e implementação de uma matriz de intervenção adaptada às necessidades locais. O objetivo é promover espaços para a promoção e prevenção em saúde, além de oferecer um cuidado integrado na Atenção Básica. A proposta inclui a realização de encontros de avaliação e adequação para garantir que a implementação seja eficaz e atenda às necessidades da comunidade local[8].

Adicionalmente, uma perspectiva valiosa sobre as estratégias de promoção da saúde e prevenção ao uso de drogas na Atenção Primária pode ser exposta ao se tratar de matriciamento. Um estudo qualitativo, desenvolvido na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de um município do Rio Grande do Sul, destaca a necessidade urgente de investimentos e suporte para melhorar as ações de promoção da saúde e prevenção. O artigo identifica o matriciamento como uma potencialidade para fortalecer a atuação da Atenção Primária, sugerindo que um maior investimento na formação e no suporte das equipes pode ter um impacto significativo na qualidade e eficácia dos cuidados oferecidos na Atenção Básica[10].

Verificar a consistência da referência 7. O texto original menciona um estudo qualitativo na Região Sul do Brasil que revelou um descompasso entre intenções e expectativas, mas a referência 7 (OLIVEIRA, Gustavo Costa de. Ações do apoio matricial na Atenção

Primária à Saúde: estudo fenomenológico) não especifica a região. É importante garantir que a referência citada corresponde exatamente ao conteúdo descrito.

Por fim, é crucial incorporar uma perspectiva culturalmente sensível no planejamento e na prática do Apoio Matricial. Embora os profissionais reconheçam a importância dos condicionantes socioculturais nos casos clínicos e nas interações com usuários e comunidades, a competência cultural ainda é considerada insuficiente para uma compreensão crítica da diversidade cultural. Estimular o debate sobre as dimensões socioculturais e considerar as particularidades culturais pode representar um avanço significativo no cuidado colaborativo, ajudando a superar desafios e potencializando as práticas matriciais. Assim, integrar a cultura no planejamento e na prática pode melhorar a adesão e a eficácia das intervenções em saúde[5].

Conclusão

O Apoio Matricial representa uma evolução significativa na forma como a APS aborda as complexidades de saúde da população. Ao integrar saberes e práticas, esta estratégia não apenas fortalece a capacidade de resposta das eSF e do NASF, mas também promove uma abordagem mais humanizada e centrada no paciente. A colaboração interdisciplinar, baseada em evidências e focada no paciente, é essencial para enfrentar os desafios contemporâneos da saúde pública, garantindo cuidados mais integrados e eficazes.

REFERÊNCIAS

[1]COHEN, Marina Chansky. Impasses e potências: o matriciamento como dispositivo de cuidado. Interface (Botucatu, Online), v. 25, e200462, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/Interface.200462>.

[2]Como o apoio matricial pode ser desenvolvido na Atenção Básica em Saúde/Atenção Primária em Saúde? Biblioteca Virtual em Saúde, 2015. Disponível em: <https://aps-repo.bvs.br/aps/como-o-apoio-matricial-pode-ser-desenvolvido-na-atencao-basica-em-saudeatencao-primaria-em-saude/>. Acesso em: 14 ago. 2024.

[3]GUSMÃO, Ricardo. Atuação do enfermeiro em saúde mental na estratégia de saúde da família. Journal of Health and Biological Sciences, v. 10, n. 1, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.12662/2317-3076jhbs.v10i1.3721.p1-6.2022>.

[4]FAGUNDES, Giselle Soares. Matriciamento em Saúde Mental: análise do cuidado às pessoas em sofrimento psíquico na Atenção Básica. Ciência & Saúde Coletiva, v. 26, n. 6, pp. 2311-2322, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232021266.20032019>.

[5]IGLESIAS, Alexandra. Matriciamento em Saúde Mental: práticas e concepções trazidas por equipes de referência, matriciadores e gestores. Ciência & Saúde Coletiva (online), v. 24, n. 4, pp. 1247-1254, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232018244.05362017>.

[6]IGLESIAS, Alexandra. Conhecendo o matriciamento em saúde mental pela perspectiva dos matriciadores. Espaç.saúde, v. 22, 2021, pp. 1-12, 24. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1353631>.

[7]OLIVEIRA, Gustavo Costa de. Ações do apoio matricial na Atenção Primária à Saúde: estudo fenomenológico. Acta Paulista de Enfermagem (online), v. 32, n. 6, pp. 674-682, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-0194201900093>.

[8]SANTANA, Elisangela Ferreira de. Proposta de Matriciamento em Saúde Mental nos municípios da Região de Saúde de Cruz das Almas. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) - Escola Estadual de Saúde Pública, Salvador, 2019. Disponível em:

<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1129712>.

[9]SANTOS, Angela Maria. O matriciamento em saúde mental como dispositivo para a formação e gestão do cuidado em saúde. Physis: Revista de Saúde Coletiva (online), v. 30, n. 04, e300409, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-73312020300409>.

[10]SANTOS, Elitiele Ortiz dos. Avaliação das estratégias de promoção da saúde e prevenção ao uso de drogas na rede psicossocial. Escola Anna Nery (online), v. 27, e20220110, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2022-0110pt>.

[11]SOUSA, Paulo Henrique Caetano de. Relato da implantação do matriciamento em um município cearense: dos desafios às conquistas. Rev. baiana saúde pública, v. 45, n. 4, pp. 241-251, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.22278/2318-2660.2021.v45.n4.a3422>.

[12]VASCONCELO, Marilena Silva de. Conhecimento de gestores e profissionais da rede de atenção psicossocial sobre matriciamento em saúde mental. Ciênc. cuid. saúde, v. 18, n. 4, e43922, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.4025/cienccuidsaude.v18i4.43922>.

[13]YAMAGUTI, Claudiney Augusto. Grupos de reflexão em Saúde Mental: possibilidade de interlocução entre a Saúde Mental e a Atenção Básica no município de Itapevi – SP. BIS, Bol. Inst. Saúde (Impr.), v. 20, n. 1, pp. 132-138, 2019. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1009105>.

Links para Atualização:

1. *Ministério da Saúde - Cadernos de Atenção Básica: Saúde Mental: < https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/dapes/cgsm/publicacoes/cadernos-de-atencao-basica-saude-mental>*

2. *Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) - Matriciamento em Saúde Mental: < https://www.sbmfc.org.br/noticias/matriciamento-em-saude-mental-na-atencao-primaria-a-saude/>*

3. *Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde: < https://www.paho.org/pt/topicos/atencao-primaria-saude>*